Onde o seu hospital dia *perde dinheiro*

Ficha de diagnóstico dos quatro pilares, versão hospital dia. Aplicada no primeiro encontro, antes de qualquer plano.

Como usar. Esta ficha é o primeiro encontro inteiro. Preencher junto, à mão, com os mentores presentes e com quem de fato opera a casa: o dono, o administrador e a coordenação de enfermagem. Metade do valor está no que eles dizem enquanto pensam na resposta.

O que esta ficha tem a mais que a do consultório. Sala, escala, convênio, glosa e corpo clínico. São as quatro frentes onde o hospital dia perde dinheiro sem perceber, e nenhuma delas existe num consultório.

Sigilo. Tudo o que está escrito aqui é confidencial entre a casa e a Sena e Bittar, e não sai desta sala sem autorização.

A casa

RAZÃO SOCIAL _____ CNPJ _____

NOME FANTASIA _____ CNES _____

RESPONSÁVEL TÉCNICO _____ REGISTRO PROFISSIONAL _____

SALAS CIRÚRGICAS _____ LEITOS DE CURTA PERMANÊNCIA _____ TEMPO DE OPERAÇÃO _____

ESPECIALIDADES ATENDIDAS _____

EQUIPE CLT _____ EQUIPE PJ _____ MÉDICOS QUE OPERAM AQUI _____

REGIME TRIBUTÁRIO ATUAL _____ FATURAMENTO MÉDIO MENSAL _____

ALVARÁ SANITÁRIO, VALIDADE _____ DATA DO DIAGNÓSTICO _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO

☐ Cirúrgico ambulatorial ☐ Exames e diagnóstico ☐ Infusão e terapias ☐ Internação de curta permanência ☐ Pronto atendimento

ORIGEM DO FATURAMENTO

☐ Só particular ☐ Maioria convênio ☐ Misto, equilibrado ☐ SUS também

O QUE SÓ EXISTE AQUI

SALA E ESCALA

Sala parada custa igual a sala cheia.

O SISTEMA MEDE · Horas de sala usadas, sobre as horas disponíveis

01 **Quantas salas existem, quantas horas por dia elas poderiam rodar, e quantas rodaram no mês passado?**

02 **Quem monta a escala, e o que acontece quando um cirurgião cancela em cima da hora?**

A sala vazia daquele dia aparece em algum relatório?

03 **Quanto custa uma hora de sala, contando equipe, material e estrutura? Quem fez essa conta?**

04 **Qual o intervalo médio entre uma cirurgia e a próxima na mesma sala?**

05 **Material e OPME: quem compra, quem negocia, e quem confere o que foi usado contra o que foi cobrado?**

O QUE SÓ EXISTE AQUI

CONVÊNIO E GLOSA

Faturar não é receber. Receber não é receber inteiro.

O SISTEMA MEDE · Glosa do mês, sobre o faturado em convênio

06 **Quais convênios respondem pela maior parte do faturamento, e qual o prazo real de recebimento de cada um?**

07 **Qual foi o percentual de glosa do mês passado? Quem recorre, e até quando?**

08 **A tabela de cada convênio foi renegociada quando, e quem conduziu?**

09 **Existe procedimento que vocês fazem sabendo que dá prejuízo no convênio? Qual, e por que continua?**

10 **Se o maior convênio saísse amanhã, quanto do faturamento iria junto?**

O QUE SÓ EXISTE AQUI

CORPO CLÍNICO

O paciente escolhe o médico. A casa recebe por tabela.

11 **Quantos médicos operam aqui, e com que vínculo: sócio, PJ, credenciado?**

12 **Qual o critério de repasse, e ele está escrito em contrato?**

13 **Quantos desses médicos trazem paciente próprio, e quantos só usam a estrutura?**

14 **Se o médico que mais fatura sair amanhã, quanto do faturamento vai embora com ele?**

PILAR 01 DE 04

GESTÃO

A base. O resto se apoia nela.

O SISTEMA MEDE · Sobra do mês, depois de imposto e retirada

15 **A contabilidade fecha o mês até que dia, e quem lê o resultado antes de o mês seguinte começar?**

16 **Existe centro de custo separado por sala, por convênio e por especialidade?**

17 **Qual é o regime tributário hoje, quem decidiu por ele, e quando foi revisto pela última vez?**

18 **Sócios têm pró-labore definido, ou a retirada sai conforme o caixa permite?**

19 **Quanto da folha é CLT e quanto é PJ? Existe alguma contestação em curso?**

PILAR 02 DE 04

MARKETING

O paciente certo precisa te encontrar.

O SISTEMA MEDE · Pacientes novos no mês, e quantos chegaram por indicação

20 **O paciente escolhe a casa, ou escolhe o médico e vem junto? Em que proporção?**

21 **De onde veio cada paciente novo do mês passado: médico daqui, convênio, busca própria, indicação?**

22 **O que a casa comunica hoje por conta própria, e quem cuida disso?**

23 **O médico que encaminha e não opera aqui é tratado como cliente? Quem fala com ele, e com que frequência?**

PILAR 03 DE 04

VENDAS

Consulta marcada ainda não é paciente tratado.

O SISTEMA MEDE · Procedimentos realizados, sobre os orçamentos do mês

24 **De cada dez orçamentos de procedimento particular, quantos são realizados?**

25 **Quem apresenta o valor ao paciente particular, e quanto tempo depois da indicação?**

26 **O que acontece com o paciente que foi orçado e não marcou?**

27 **Qual o percentual de cirurgias agendadas que não acontecem, e por quê?**

Desistência, exame pendente, autorização do convênio, agenda do cirurgião?

PILAR 04 DE 04

LUCRATIVIDADE

Faturar mais e lucrar mais são contas diferentes.

O SISTEMA MEDE · Margem líquida do mês, contra a meta do trimestre

28 **Qual procedimento dá mais margem por hora de sala? E qual ocupa mais a sala?**

Se as duas respostas forem diferentes, está achada a primeira correção.

29 **Qual o ponto de equilíbrio do mês, em número de procedimentos?**

30 **Há quanto tempo a tabela particular não é reajustada?**

31 **Se a demanda dobrasse amanhã, o que quebraria primeiro: sala, equipe, material ou recebimento?**

A CONTA QUE QUASE NINGUÉM CONFERIU

A redução de 60% de IBS e CBS alcança serviço hospitalar e ambulatorial, pelos arts. 128 a 134 da LC 214/2025. O benefício depende de o serviço estar corretamente classificado na NBS: código errado perde o redutor, mesmo sendo saúde de fato.

32 **Como cada serviço aparece hoje na descrição da nota fiscal, e sob qual código?**

Quem definiu essa descrição, e quando?

FECHO DO ENCONTRO

LINHA DE PARTIDA

É contra estes seis números que os 90 dias vão ser medidos.

INDICADOR	HOJE	COMO FOI APURADO
Sobra do mês depois de imposto e retirada		
Ocupação de sala horas usadas sobre horas disponíveis		
Glosa sobre o faturado em convênio		
Pacientes novos e quantos por indicação		
Procedimentos realizados sobre os orçamentos do mês		
Margem líquida sobra dividida pela receita		

Se algum destes seis não puder ser apurado hoje, escrever "não sei" em vez de estimar. Saber que não se sabe já é diagnóstico.

O que a casa entrega até o próximo encontro

- Extrato bancário dos últimos 6 meses
- Faturamento mês a mês dos últimos 12 meses, separando convênio, particular e SUS
- Demonstrativo de glosa dos últimos 3 meses, por convênio
- Tabela de preço particular e as tabelas dos convênios vigentes
- Mapa de ocupação de sala dos últimos 3 meses
- Guias de imposto dos últimos 6 meses
- Folha de pagamento e relação dos PJs
- Contratos do corpo clínico e o critério de repasse
- Amostra de notas fiscais emitidas, para ver como o serviço está descrito
- Alvará sanitário e licenças vigentes

As três decisões do trimestre

Três. Não dez. Escritas aqui, na frente deles, antes de todo mundo levantar.

DECISÃO 1

DECISÃO 2

DECISÃO 3

ASSINATURA PELA CASA

PELA SENA E BITTAR

“A agenda lota. O caixa não acompanha.”

SENA · BITTAR